



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 07-11-2024 8:04:09

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Manuel Jesus Cuevas Vasquez	Rut : 10.320.258-2	N° Archivo : 2119260	N° Epicrisis
Edad : 59a 6m 22d	Fecha Nacto : 16/04/1965	Sexo : Masculino	419676
Dirección : San Pedro 365 Pb San Marta	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 9 8397 0554	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)	Fecha Ingreso : 22/10/2024	17:33	Días Estadía : 16
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso : 07/11/2024	08:11	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Anasarca

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

INGRESO A UCI DESDE UTIM HOY 06/11/2024 A LAS 01:00HR

MANUEL JESUS CUEVAS VASQUEZ
59 AÑOS
10320258-2

ANAMNESIS:

Paciente con antecedentes descritos es derivado desde CDT Nefrología por anasarca y alteración de la función renal e hidroelectrolítica (Crea 4.28 (10/10 en 3.5), BUN 51.6, K 3.1, Alb 0.5, Ca 6.4 (9.2c)). Al interrogatorio dirigido refiere aumento de edema de EEII desde última hospitalización, mareos y disnea en relación a esfuerzos, además de 5 días de diarrea. Ingresa al Servicio de Urgencias en regulares condiciones generales, PA 91/50 (PAM 63), FC 68, afebril, Sat 94% amb, con edema generalizado al examen físico, sin otras alteraciones descritas.

Del estudio inicial destaca Crea 7.0, BUN 72, ELP 134/2.4/114, Alb 0.6, Ca 6.8 (9.5c), Hb 6,1, GB 10280, Plaq 69000, PCR 176. Rx Tx impresiona sin focos de condensación ni derrame pleural, impresiona con leve cardiomegalia.

Evaluable por Nefrología, indican instalar CHD tunelizado, cronificar por conflicto de volumen y evaluar eventual nefrectomía médica, Carga K + Mg, diuréticos post carga, continuar CyborD ajustado a función renal.

Dado paciente con síndrome nefrótico severo, se hospitaliza en UTIM para manejo.

30/10: HEMATOLOGÍA Dr. Blanco:

Evaluable paciente con diagnóstico de Amiloidosis AL, recibiendo ciclo 2 de CYBORD, con deterioro de la función renal en estos momentos y trombocitopenia y anemia asociada.

Se trata de enfermedad potencialmente recuperable con esquema Daratumumab- CyBorD (solicitado pero sin respuesta aun del hospital), con opciones de trasplante de médula ósea según normas MINSAL.

10/10/24: plt: 153000 HB: 7,2 L: 9,19 RAN: 7600
22/10/24: HB: 6,1 L: 10300 PLT: 69000
29/10/2024: HB: 7,3 L: 6,54 RAN: 6,2 PLT: 16 000

Fecha Epicrisis : 07/11/2024 08:04

Página 1 de 5

En suma paciente con amiloidosis AL en quimioterapia, trombocitopenia severa, tiempos de coagulación dentro de rango Dímero D > 12000, se necesita descartar microangiopatía secundaria.

Plan

- Realizar Hemograma formal, reticulocitos y haptoglobina.
- Reevaluar con resultados.
- Eritropoyetina 4000 unds Sc lunes miércoles y viernes.
- Acido fólico 5 mg diario.

FI URG: (22/10)

FI UTIM: (23/10)

IOT: (05/11) Epistaxis, sialorrea, Anasarca

FI UCI: (06/11) 01:00

DIAGNÓSTICOS:

1. SHOCK SÉPTICO FOCO GASTROINTESTINAL
 - a. Bacteriemia Bacilos G(-) 9hr (05/10)
 - b. Gastroenteritis en manejo en inmunosuprimido
 - ** Obs Diarrea por CD no complicada 1er episodio
 - ** HipoK moderada en manejo
2. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA PARCIAL EN MANEJO
 - a. EPA
 - b. IOT (05/11)
3. ANASARCA EN MANEJO
 - a. Sd Nefrótico 2río a Amiloidosis AL en Quimioterapia (CL lambda) (rojo congo +)
 - ** 1° ciclo CyborD 08/09
 - ** 2° ciclo CyborD 03/10
 - b. Hipoalbuminemia severa alto riesgo trombótico
 - c. EPA con compromiso de vía aérea IOT (05/11)
4. HIPOGLUCEMIA SEVERA RESUELTA (05/11)
 - a. HGT 12mg/dl.
5. AKI KDIGO III/ERC - AMILOIDOSIS
 - a. HD TRR tunelizado YI: HD FI 26/10
6. PANCITOPENIA EN SEGUIMIENTO POR HEMATO
 - a. Aplasia post QT??
 - b. Anemia severa trasfundida
 - c. Trombocitopenia severa
7. TRASTORNO DEGLUTORIO
8. SHOCK DISTRIBUTIVO

ANTECEDENTES: Amiloidosis AL (compromiso renal) en QMT (CYBORD 1° 08/09, 2° 03/10), Sd nefrótico, EAo periférica (bypass 2023), Trombosis aórtica torácica, Hipotiroidismo

ANTECEDENTES:

Médicos: Amiloidosis cadenas lambda (rojo congo +) con compromiso renal (debut mayo 2024, 1° ciclo CYBORD 08/09/24, 2° ciclo 03/10/24), Síndrome nefrótico 2°, EAo periférica (isquemia crítica EID°, manejado con embolectomía + bypass en 2023), Trombosis aórtica torácica, Hipotiroidismo. ECOG 2-3

Estudio Síndrome nefrótico:

- AntiPLA2R (-) Hb1AC 4.9% (con anemia) ANA (-) ENA (-) VHB NR VHC NR VIH NR VDRL (-)
- APE (-), Estudio de tubo digestivo con EDA + colono sin hallazgos sugerentes de neoplasia.
- Bp renal (11/06/24): Amiloidosis renal primaria con reactividad exclusiva cadenas livianas lambda con compromiso glomerular,

Fecha Última Actualización: 07-11-2024 8:04:09

Página 3 de 5

arterial e intersticial discreto, daño pedicular moderado, atrofia tubular 20% y fibrosis intersticial 10%, rojo congo (+)

- Cadenas livianas: K 67.4, L 97.3, R: 0.6931

- EFP: Paraproteína en zona Beta 2 0.6g/dL 7,6%

- Ecocardio: FE 70%, VI tamaño normal, AI dilatada, dilatación cavidades derechas, PSAP 41 mmHg. Nota: Hallazgos no concordantes con amiloidosis cardíaca.

- BMO 22/08/24: Celularidad disminuida (10 - 20%) a costa de elementos de las tres series. Megacariocitos presentes, de aspecto conservado. Sin elementos atípicos. IHQ para rojo Congo sin depósitos amiloides. Escasos plasmocitos normotípicos, aislados y en pequeños grupos laxos, positivos para CD138 y MUM1 y negativos para CD56. Linfocitos T pequeños, dispersos, reactivos para CD3. Escasos linfocitos B normotípicos positivos para CD20. Estudios de CISH para cadenas livianas Kappa y Lambda muestran patrón de expresión polipático.

Conclusión: médula hipocelular sin evidencias de amiloidosis, de neoplasia linfoproliferativa ni de neoplasia de células plasmáticas.

- CMF en MO (26/08/24): 0.55% de células plasmáticas, de las cuales, el 63% (0.35% del total de células nucleadas) corresponde a patológicas, positivas para CD38/CD138, CD117 y CD27 débil, negativas para CD45, CD19 y CD81. 0.3% blastos mieloides, 62% granulocitos, 3% eosinófilos, 11.5% monocitos, 21% linfocitos, 0.5% basófilos y 1% eritroblastos.

Diagnóstico: Presencia de 0.35% de células plasmáticas patológicas.

Quirúrgicos: Embolectomía + Bypass (mayo 2023)

Fármacos: Cotrimoxazol F Lu-Mi-Vi, Aciclovir 400 mg c/12 hrs, Omeprazol 20 mg/día, ATV 80 mg/día, Levotiroxina 50 mcg/día, Dapagliflozina 10 mg/día, Rivaroxaban 20 mg/día

Alergias: No conocidas

Hábitos: TBQ suspendido en 2023 (previamente IPA 15), OH suspendido (previamente 4 garrafas de vino los FDS), Otras drogas (-)

Hospitalizaciones recientes:

·16/05-17/06/24 por síndrome nefrótico

·14/08-05/09/24 por anasarca en contexto de mala adherencia a terapia (adherencia dificultada por comprensión limitada del paciente)

Sociales: Trabajaba como maestro independiente, actualmente en gestión Pensión de Invalidez. Vive solo. Realiza ABVD con dificultad (por síntomas). Tutora hermana.

Evolución 06/11

HDN: Cursando shock distributivo-septico bajo soporte de doble dva con NAD 0.4 mcg/kg/min + Vasopresina 0.03 ui/kg/min, con hipoperfusión clínica marcada con último Ac. Lactico: 36, no ha presnetado signos de snagrado activo, sin falla de bomba, continuaur renimación segun parametros de perfusión.

CV: ICC FEp (70% en ago/24), sin hallazgos de amiloidosis cardiaca. Ingresa en anasarca con ProBNP 19.866 y tendencia a hipotensión. Nuevo ETT FE 66% sin amiloidosis. Por el momento, se difiere mayor estudio.

RENAL: Sd nefrótico secundario a amiloidosis renal por CL lamda en biopsia. VEC aumentado en anasarca, se revalúa en conjunto con jefatura y equipo de nefrología quien define podría beneficiarse de hemofiltración continua, viene con hipokalemia persistente por diarrea y acidosis metabólica por lo que ha recibido cargas diarias de potasio y aporte oral de bicarbonato, control diario para corrección oportuna.

INFECCIOSO: Diarrea en inmunosuprimido, Completó 7d de tazonam empírico. Dado sin reactivo para toxina C. difficile, se decide tratamiento empírico con Vancomicina VO (FI 27/10), se escala a manejo dosis de diarrea severa por CD (Vanco 500 y asociado a Metronidazol). En plan de tomar muestra para PCR C. difficile (orden ya impresa, autorizado por infectología). Además PCR CMV en sangre y colonoscopia para biopsia y CMV de tejido. Se rescata HC y CVC del 05/11 con Bacteremia x Serratia marcescens NDM aun sin seceptibilidad, se optimiza manejo con Ceftazidima/avibactam + aztreonam, con parametros al alza con PCR: 312-->323, sin fibre muy hipoperfundido, monitoreo estrcito y espera de repuesta terapeutica.

HEMATO-ONCO: Amiloidosis AL, en día +34 de 2° ciclo CyBorD, en espera de 3er ciclo, ealuado por hematología, se determina pronóstico favorable si logra recibir daratumumab-CyBorD (solicitado a principios de septiembre, aún sin respuesta por dirección de hospital). Actualmente cursando con anemia y trombocitopenia severa, a lo que se agrega hoy neutropenia. Podría ser aplasia post QT +/- sepsis sobreagregada.

NUTRICIONAL: Bajo regimen cero por inestabilidad hemodinamica, hipoglicemias sostenidas, se adiciona infusión de SG 30%,

Fecha Epicrisis : 07/11/2024 08:04

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 07-11-2024 8:04:09

Página 4 de 5

control seriado

ETE: Anticoagulado por hipoalbuminemia severa y trombosis aórtica. Suspendida actualmente por trombocitopenia severa hoy con . Sin nueva exteriorización de sangrado, se reinició tromboprofilaxis por estabilidad de plaquetas pero hoy 28.000, y anemia en corrección.

NOTA 07:55 horas:

Paciente en shock refractario con doble DVA NAD: 0.4 mcg/Kg/min, + Vasopresina 0.04 UI/min, en HFAV (hemodfiltración de alto volumen) hace 17 horas, con poca respuesta dado a persistencia de hiperlactatemia, con hipoxemia refractaria, quien presenta en PCR - asitolia en monitor, se comprueba ausencia de pulso y se inician maniobra de RCP avanzada por 15 minutos sin respuesta y se declara fallecido. Hora de muerte 07:35 horas.

Se comunica a familiares - Hermana (Tutora).

Diagnóstico de Egreso

Shock septico - 1. SHOCK SÉPTICO FOCO GASTROINTESTINAL

- Bacteriemia Bacilos G(-) 9hr (05/10)
- Gastroenteritis en manejo en inmunosuprimido
 - ** Obs Diarrea por CD no complicada 1er episodio
 - ** HipoK moderada en manejo

2. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA PARCIAL EN MANEJO

- EPA
- IOT (05/11)

3. ANASARCA EN MANEJO

- Sd Nefrótico 2rio a Amiloidosis AL en Quimioterapia (CL lambda) (rojo congo +)
 - ** 1° ciclo CyborD 08/09
 - ** 2° ciclo CyborD 03/10

- Hipoalbuminemia severa alto riesgo trombótico
- EPA con compromiso de via area IOT (05/11)

4. HIPOGLUCEMIA SEVERA RESUELTA (05/11)

- HGT 12mg/dl.

5. AKI KDIGO III/ERC - AMILOIDOSIS

- HD TRR tunelizado YI: HD FI 26/10

6. PANCITOPENIA EN SEGUIMIENTO POR HEMATO

- Aplasia post QT??
- Anemia severa trasfundida
- Trombocitopenia severa

7. TRASTORNO DEGLUTORIO

8. SHOCK DISTRIBUTIVO

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Hora de muerte: 07: 35 horas

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 07/11/2024 08:04

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:40

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 07-11-2024 8:04:09

Página 5 de 5

John Gutierrez González

Médico Tratante (Staff)

INTERNO

Becado/Residente